

15:30
X/14800 227 315166

INDICADO POR: Dr. Camoapra / Dr. Boldrin
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

ANTONIO RICARDO SILVEIRA FERREIRA

IDADE: 38 PESO: 106 ALTURA: 1,89 PROFISSÃO: ADM

SINTOMAS: cansaço e sonolência diurna

QUEIXAS: sono intermitente

MEDICAMENTOS: não - Maquero (Bisgimate)

MÉDICO: Dra Camila Teledo / Dr. Boldrin (Pneumo) / Dr. Abeardo.

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 19-19:30

HORA QUE DORME: 23h - 0:30h HORA QUE ACORDA: 6-7h

COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1-2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 60cm SPO2: 64% / spo2 86%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Distrofia neuro muscular / Fadiga
estomatodis

CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAFIA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

15/05/25 Anulação p/ titulação

P = 10 cmH₂O
IAH = 15,2 e lev
SpO₂ min = 71%
SpO₂ med. = 90%

11/06/25 2º início da adaptação de
Bipap (modo auto)
IPAP = 13,0
EPAP = 9,0

18/06 25 IPAP = 12 / EPAP = 8 / máx. Duam Pillow
IAH = 12,2 e lev
fuga = 15,0 l/min
m. de uso: 7hr
4cmH₂O PS

✦ IPAP = 10 EPAP = 6 PS 40 cmH₂O.

04/07
25

(P=) IPAP = 10 cmH₂O

EPAP = 6 cmH₂O

IAH = 12.9

AC = 8.6 elev

IH = 1.9 elev

fuga = 17.1 med

Dias
23/23

18 h (4 h)
5 h 4 hrs.

Biologia

2d

lua.

IPAP = 10

EPAP = 6

Fuga = 14.9

M. de uso: 7hs

IAH = 15.1 (AC = 8.6 / AO = 35)

lua.

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: ANTONIO RICARDO SILVEIRA

Data do Exame: 04-04-2025

Peso: 110 kg

Médico Solicitante: DRA. CAMILA TOLEDO TURANO

Sexo: Masculino

Idade: 38 anos

Altura: 1,89 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 04/04/2025 21:35 e finalizado às 05/04/2025 05:43.

A latência para início do sono foi de 13,0 min e a latência para o sono REM de 120,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 428,0 min, com eficiência do sono de 88,2 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 6,2 % de estágio N1, 47,4 % de estágio N2, 27,6 % de estágio N3 e 18,8 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 44,4 min. Ocorreram 142 despertares, sendo o índice de 17,4 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 431, sendo 100 apneias obstrutivas, 1 apneias centrais, 0 apneias mistas, 330 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 60,4 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 64,1 e o IDR durante o sono NREM foi de 59,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 60,4 (nº/h), sendo 14,2 apneia/h e 46,3 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 86% e a mínima de 64%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 59,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 105,8 (nº/h) e em NREM foi de 59,4 (nº/h). Permaneceu 66,8 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Data do Exame: 04-04-2025

Nome: ANTONIO RICARDO SILVEIRA

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (60,4 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (64%);
3. Latência para o início do sono (13,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (120,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (88,2 %) (VN= $\geq$ 85%);
6. Índice de despertares 17,4 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (6,2 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (47,4 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (27,6 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (18,8 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

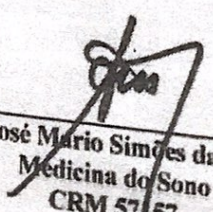
Exame evidenciando Índice de distúrbio respiratório e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Paciente: **ANTONIO RICARDO SILVEIRA FERREIRA** (38
anos)
Convênio: **Bradesco**
Matrícula: **954490036692007**

Relatorio medico.

*Paciente com indicação de uso de CPAP na pressão titulada de
10,0 cm de H2O. Fazer ajuste fino da pressão*

São José dos Campos, 04 de junho de 2025

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (60,4 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (64%);
3. Latência para o início do sono (13,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (120,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (88,2 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares 17,4 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (6,2 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (47,4 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (27,6 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (18,8 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

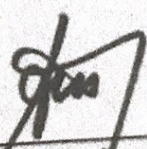
Exame evidenciando Índice de distúrbio respiratório e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Data do Exame: 04-04-2025

ALC DRº Beldium

O 5º Anterior - Mente S. Feneira, HB.: AOS+

Distúrcia Muscular.

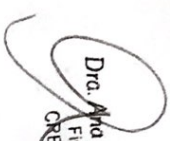
Ele fez a Trilulação e CPAP com pres-
são de 10 cmHg, SpO₂ média 90%, per
6h28', IAH = 15.2 e lcv.

Com o BIPAP = Pressão 10 IPAP e 6 EPAP
teve apneia central de 8.6 e lcv na
média, IDO foi de 33%, em 18% do
tempo total de sono. Houve uma
melhora significativa, porém, ele
continua tendo queda de saturação
em algumas fases do sono (no
gráfico do biologia, sugere que na
fase REM. Sonda assim, vamos
→

Dra. Ana Cláudia de Matos
Fisioterapeuta

CREFITO 29544-F

precisar de mais tempo, para que
haja acomodação do sistema re-
vivo central, para que eu possa
regular o BIPAP.
Em anexo segue os dados do
CPAP / BIPAP e Oximetria noturna.
Fico a disposição

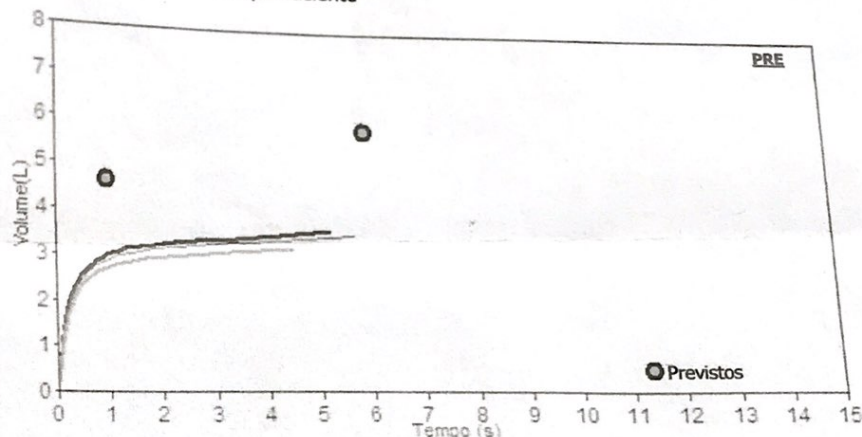
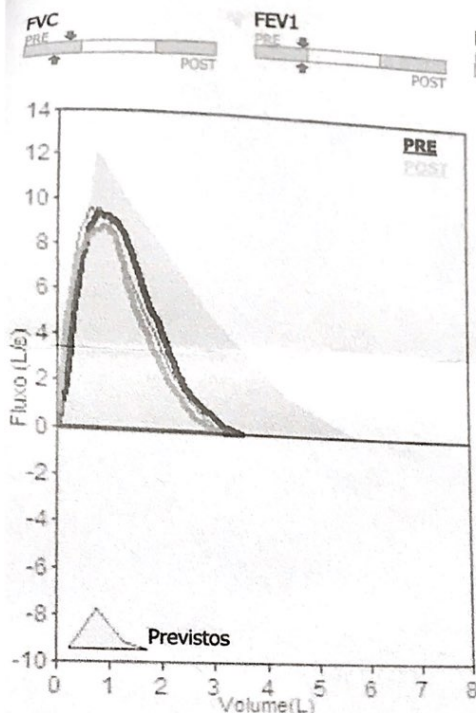

Dra. Ana Cláudia de Matos
Fisioterapeuta
CREFITO 29544-F

14/07/25

Data da Visita 18/07/2025

Cód. Paciente WSP239025354
 Sobrenom ferreira
 Nome antonio ricardo s.
 Data de Nascimen 08/12/1986
 Grupo Étnico Não Definido
 Fumante Não Fumante
 Grupo Paciente

Idade 38
 Sexo Masculino
 Altura, cm 189
 Peso, kg 106
 BMI 29,67
 Pacotes-Ano



Controle de Qual. Grau: F Variabilidade: FEV1=0,15L (5,19%), FVC=0,11L (3,21%)
 0 Acceptable trials

Interpretação

Restrição Moderada
 Broncodil. ão significativa

PRE data da Curva 18/07/2025 18:12:49

POS broncodilatador com Salbutamol - 18:22:00

Parâmetros	LLN	Prev	Best	%Prev	Z-score	PRE#1	PRE#2	PRE#3	POST	%Prev	%Des
FVC	I	4,90	5.80	3,54*	61	-4.14	3,54	3,43	3.14*	54	-11
FEV1	I	3,88	4.64	3,04*	65	-3.47	3,04	2,89	2.73*	59	-10
FEV1/FVC	%	72,1	79.7	85,9*	108	1.33	85,9	84,3	86.9*	109	1
PEF	l/s	9,30	12.23	9,60*	78	-1.47	9,53	9,60	8.96*	73	-7
ELA	Anos		38	102	268		102	108	114	300	12
FEF2575	l/s	2,47	4.18	3,76	90	-0.40	3,76	3,55	3.73	89	-1
FET	s		6.00	5,23	87		5,23	5,71	4.51	75	-14
FVC	I	4,90	5.80								
FEV1/VC	%	72,1	79.7								

*Melhores valores de todas as curvas - BTPS 1,097 24 °C (75,2 °F) - Previstos Pereira 2008-2012

Conclusão / Laudo Médico

Assinatura

CAPACIDADE VITAL = 61% do
 PREVISTO, MELHOR RESULTADO
 DESDE O INÍCIO DA DOENÇA
 MENIN, ENBORA NÃO SE POSSA
 AFINAR QUE SE DEUS OS
 CUIDADOS ATUAIS

Instrumento er
 Spirobank II new S/N YC

Dr. Roberto Boldrin Junior
 Pneumologia
 CRM 33.148